

Les tissus, en embryologie classique, on en parle de trois tissus, ecto, endo, meso. Dans l'histologie, on parle de deux tissus, et on pourrait résumer ces tissus histologiques en deux grands types de tissus. Des tissus épithéliaux, d'origine ectodermique, des tissus épithéliaux d'origine endodermique, en d'autres mots, des tissus épithéliaux d'origine neurologique, des tissus épithéliaux d'origine... T'es ouf ! digestif, ou ici des tissus conjonctifs, connectifs, d'origine mésodermique. J'ai rajouté ici une couche qui commence à rentrer dans le processus de Blech-Schmidt, deux qualités de tissus sur un plan de mouvement, et rejoint en fait un peu l'histologie. Finalement, il dit, j'ai du tissu de limite, ou ce qu'il appelle du tissu de frontière, ou j'ai du tissu d'intérieur, ce qu'il appelle du tissu de conjonctif. Il dit, le tissu de limite, c'est toujours l'ectoderme et l'endoderme, et le tissu d'intérieur, c'est toujours le mésoderme. Quand je prendrai du rouge, en général, je vais dessiner toujours ce qui est représentatif de l'endoderme, ou plus spécifiquement du système digestif. Quand je vais prendre du bleu, Je vais prendre essentiellement le tissu ectodermique. Quand je prendrai du verre, essentiellement mesodermique, qui vient dès que j'étudie et je vois que je suis sur une artère. Moi dans ma tête, ça va tout de suite, c'est une artère, un mésoderme, tissu d'intérieur. Je sais où je suis dans le système, donc je reconnais une dynamique déjà, ça me permet de me situer.

Sous-titrage ST' 501 C'est le lien entre l'histologie... l'embryologie et l'embryologie biodynamique. C'est une représentation un peu du tissu ectodermique, épithélial, c'est-à-dire, c'est un tissu qui est concentré entre un liquide et un tissu d'intérieur. Pourquoi ? Si j'ai la mer, et au centre, entre les deux, j'ai un tissu d'intérieur. C'est un tissu d'intérieur. Et en bas, j'ai la Méditerranée. tissu mesodermique, un tissu endodermique, aussi concentré, on voit souvent près des mers, comme ça, tu vois, une concentration. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? Ça va nous expliquer des caractéristiques de ces tissus. Le tissu de

limite est toujours situé entre ce qu'on appelle le fluide et le tissu d'intérieur. Si on observe le tympan, il est fait de trois tissus. Il est fait du tissu ectodermique, à l'extérieur. À l'intérieur, il est fait du tissu endodermique. Et au milieu, il est fait du tissu mesodermique. OK ? Le tissu de frontière, donc le tissu de limite, est toujours dépendant du tissu d'intérieur. En d'autres termes, le tissu épithélial est toujours dépendant du tissu conjonctif. Parce que les vaisseaux et la nourriture viennent du tissu d'intérieur et est distribué dans le tissu de frontière. Donc, en d'autres termes, c'est le tissu mésodermique qui contient l'information trophique de croissance et de maintien de la croissance. Beaucoup plus sérieux qu'ici. Il n'existe pas de congestion dans le tissu de limite, mais qu'il peut exister des phases de congestion dans le tissu d'intérieur. Prends ces tissus et tu te rends compte qu'il y a une zone desséchée. Tu dois réhydrater, réouvrir, reconnecter. Ça peut être une congestion ou une phase d'assèchement. Et dans la vie, ça se passe. Si tu as une sécheresse, le tissu est complètement sec. S'il pleut trop, tu as des phases de congestion. Et tu as des phases de congestion naturelle aussi. Une femme a des congestions naturelles. Tous les mois, elle a une congestion utérine qui est un nettoyage parce qu'elle est prête à accueillir la vie. Si elle ne peut pas accueillir, tout le système glandulaire se rétrécit, s'élimine et elle passe vers une autre... Donc, ceci correspond un peu à la campagne. Ça veut dire que ce tissu ici, ça va donner tout le système fluidique, c'est-à-dire tous mes vaisseaux, toutes mes artères, toutes mes veines, tout mon système lymphatique. Ça va donner aussi tout le système squelettique, musculosquelettique, les os, les membranes, les péritoines, dans le crâne, tu vas appeler ça les membranes de tension réciproque. Tout le système circulatoire, tout le système urogenital et tout le système de soutien, c'est du tissu mésothermique ou, en d'autres mots, c'est du tissu d'intérieur. On retrouve dans le tissu de limite une grande variété de formes. C'est des croissances en surface.

Il n'y a pas de phase de congestion et il y a beaucoup de cellules. Il est toujours dépendant du tissu d'intérieur. Tandis que le tissu d'intérieur, l'intérieur, Lui, il est entre les deux tissus. Admettons maintenant que je reçois une bonne clouche dans la figure. Je pète. Je fais une rencontre, tu vois, la pression se fait. Et j'enlève le tissu d'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dans mon corps ? Le liquide. Je pète le tissu d'intérieur. Par exemple, deux vaisseaux qui se rencontrent. Je pète mon tissu d'intérieur, j'ai un champ de corrosion. D'une façon très simplifiée, je vois que tous les constituants du tissu conjonctif sont résumés dans ces... On résume. dans ces quatre grands composants. Maintenant, si je prends un tissu, et je vais mettre un os ici, et que je vais les comparer. Dans un os, il y a beaucoup de cellules. Par contre, j'ai peu d'eau. Il y a beaucoup de minéraux. Et là, dans les fibres, qu'est-ce que je vais avoir ? Un oeuf, un oeuf, un oeuf, un oeuf. Sous-titrage ST' 501 Il y a un peu moins de cellules, j'ai un peu plus d'eau, et pour la matrice, il y a un changement, on a une défi, puis j'ai plus d'élastique. Maintenant, si on va un peu plus loin, on a ce qu'on appelle les glycoamino-glycanes. Je rentre dans ce processus matriciel. Et qu'est-ce que je constate ? Que j'ai soit une structure qui est de type perméable, c'est-à-dire plutôt dépolymérisée, ou j'ai une structure qui est plus dense, qui est donc dense, qui est dure, donc où j'ai ce qu'on appelle une structure polymérisée. Quelle est la structure la plus dense du corps ? les ligaments, les tendons et puis on va mettre jusqu'ici le sang, on peut mettre toutes les structures de type mésodermique ici et je constate simplement que soit elle est perméable soit elle est visqueuse et si je vais par là, je vais vers quelque chose de fluide, par là je vais vers quoi ? C'est un truc... des contraintes. L'observation des dents, l'observation de l'occlusion vous donne l'image parfaite des contraintes qui se trouvent au niveau de la symphyse phéno-basilaire. Et on va voir que cette symphyse phéno-basilaire, dans l'embryologie, c'est une clé pour le corps. C'est

comme si, je pourrais appeler ça le point zéro, un point neutre qui reçoit toutes les informations du corps, que ce soit sur le plan vasculaire, lymphatique, que ce soit sur le plan neurologique, digestif, membrane de tension, etc. La symphyse phéno-basilaire est au courant de tout ce qui se passe. Et les dents vont toujours se débrouiller comme ils peuvent, s'il faut grincer des dents ou faire n'importe quoi pour donner la liberté sur ce niveau-là. Et la base des dents, l'occlusion, les dents, ce sont des capteurs de posture. Ça veut dire que c'est une relation très importante entre les dents et la notochorde. Ou plus précisément, c'est une relation très importante entre les dents et tout l'axe vertébral. Ou en d'autres mots, les dents peuvent perturber la statique. Ou en d'autres mots, une hernie discale peut être traitée en rééquilibrant l'occlusion. Les dents, ce sont elles qui peuvent prendre les contraintes, c'est elles qui gardent la charge karmique de votre vie. La santé, c'est un équilibre, on en a parlé, dans cette dynamique. C'est une harmonie qui va exprimer un état de bien-être, etc. On va prendre un tendon. J'ai un tendon. Qui lui, s'il est libre, dans sa bonne dynamique, il n'y a pas de problème, il est dans son bon réseau, il est dans un bon équilibre entre la contrainte et les fluides. Il est dans l'équilibre. Il est dans un juste échange, ok, d'informations, trophique, il reçoit ce qu'il a. Mais maintenant, il se passe qu'il y a un déséquilibre qui peut être interne, ou un déséquilibre, ce n'est pas extérieur par un... une profession, tu vois. Eh bien, tout d'un coup, le tendon, il perd sa qualité de place, et qu'est-ce qu'il fait ? Il a plus de contraintes, et donc il part par là. Et donc, qu'est-ce qu'il reçoit dans son métabolisme ? Un changement d'information. Ça va partir à donner ce qu'on appelle une tendinite calcifiante. Et qu'est-ce qui part quand j'ai une tendinite calcifiante ? Je pars vers l'os. Je me durcis. Tu vois ? Et j'attrape ici. Parce qu'on va voir en détail que les membres, c'est une expansion d'un sac péritonéal, pleurocardio-péritonéal, tu vois, dans un mouvement

spécifique. Ça va se faire au même moment que ce mouvement se fait ici, tu vois. Le résultant va se faire ici, le coude, le poignet, on va le retrouver dans le corps comme ça. Si par exemple, j'ai une hépatose ou j'ai un déficit au niveau pulmonaire ou autre, ça peut bloquer mon système de rotation. Et s'exprimer à distance ici. Tu vois ? Donc parfois, ce qui se passe ici peut être l'expression d'un déséquilibre qui se passe ici. Par cette étude de l'embryologie, ça va nous donner ce qu'on appelle les liens et les interactions des tissus. Là, l'ostase, c'est les processus qui permettent de garder l'homéostasie. Elle va tenter de rééquilibrer ceci. Donc c'est tous les processus. Et pour ça, j'ai besoin d'une force magnétique. J'ai besoin d'un... D'une électricité, d'un voltage. On a même mesuré, c'est un copain biologiste suisse qui a mesuré sur la membrane les forces électriques dans le glycocalyx qui s'exprimait, donc sur ce réseau électrique. C'est énorme, en fait, quand on va aller dans cette perception. On va travailler avec un champ micro-crystallin. Si on va aller dans cette force de perception au niveau de l'embryon, on doit affiner certaines notions ici et certaines notions ici. Vous allez voir que le toucher est extrêmement doux. Quand je touche quelqu'un, les gens disent, tiens, c'est très doux. Et en même temps, on sent que c'est très, très global, si tu veux, parce que je travaille sur ce champ micro-crystallin. On va voir que la main vient se déposer dans sa formation sur le cœur. Que vos yeux se déposent sur le cœur. Et que votre voix se dépose sur le cœur. Et que le cœur, il émet un champ rythmique déjà au 23^e jour. Très puissant, qui informe de façon pulsatine, tu vois, et de façon rythmique et de façon électrique vos mains. Ça veut dire que vous êtes informé déjà par le rythme du cœur, même dans vos regards. Et ça se fait au niveau de la thyroïde. La thyroïde, ça vient de la langue, et la langue, c'est le bourgeon du cœur. Et c'est quand je parle, à 7 ans, j'ai mon sinus qui s'ouvre, en même temps que ma thyroïde devienne complètement active sur le plan vibratoire. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'à 7 ans, je

peux faire front. Je peux commencer à me défendre avec mes mots. Avant ça, je me batte, les enfants, ils se battent avant. Et à un moment donné, ils ont l'âge de la raison. Et maintenant, tiens, j'arrive à parler. Parce que tout d'un coup, j'y reçois ma force, ici, tu vois, dans les mots. Je peux commencer à raisonner avec ma tête. C'est ça, le champ du cœur, tu vois. C'est ça qui va s'exprimer. Torsion, c'est un mouvement du sphénoïde en lien avec le maxillaire supérieur. L'occipuce reste fixe, la mâchoire reste fixe. Ça donne un mouvement de torsion. On retrouve parfois ce genre de choses chez les patients. Articulés croisés. Maintenant, dans l'image d'un, ce qu'on appelle un side bending. Regardez. Au niveau de l'occipuce. Regardez bien, cette fois-ci, occipuce, side bending, rotation. Regardez ce qui se passe au niveau de ma synphyse phénobasilaire. Regardez, vous avez vu ? Regardez ce qui se passe au niveau de la face. Torsion, c'est un mouvement du sphénoïde en lien avec le maxillaire supérieur. Un œil plus petit, un œil plus grand. Regardez Nazion, regardez la position des mâchoires. Regardez cette fois-ci le lien entre la maxillaire supérieure et la maxillaire inférieure. Regardez l'image des straines. Straines cervicales, straines au bas. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Regardez quelqu'un qui a un prognate ou un rétrognate. Ça c'est l'introduction ostéopathique qu'on va mettre dans la mise en place future de l'axe notochordel avec le développement futur du sacrum. Et de l'axe crânio-sacré primitif. C'est-à-dire que quand on va toucher un sacrum, il a l'histoire de tout ça. Et vous allez voir qu'un sacrum et une base du crâne, ça n'a aucune différence. C'est la même chose, c'est un même tissu, c'est juste un mouvement. On va voir en développement, le sacrum sera le fulcrum mobile et la base du crâne sera le point d'appui. C'est pour ça que le sacrum est à la base du développement cortical. Premièrement, je parle d'extoderme, je parle de tissu. J'ai vu. Je parle de quel tissu ? Quand on parle d'éclat d'air, je parle du tissu ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Deux limites. Sur un plan

histologique, je parle de quel tissu ? Et sur un plan de structure, quand je parle de tissu ectodermique, Je parle de tout votre système nerveux, central, périphérique et la peau autour. Donc ça, c'est du viscérocra. Ça c'est de l'eurocrime. l'un est endodermique l'autre est tectodermique quand je vous parle du viscérocral c'est la face mais c'est juste ici tout ça c'est du viscérocral je vous ai parlé je me souviens dans le petit tableau j'ai dit le tissu d'intérieur et le tissu de frontière et j'ai dit que l'un était toujours dépendant de l'autre donc le tissu de frontière est toujours dépendant du tissu d'intérieur en d'autres termes je ne peux pas parler du développement du système nerveux sans son emballage qui est son système mésodermique ou en d'autres termes qui sera toutes les membranes de tension ou en d'autres termes qui sera de la durmère et tout son système auto je ne peux pas en parler je ne peux pas les séparer même chose je ne peux pas vous parler du tube digestif sans vous parler du péritone mais le péritone ce n'est pas de l'endoderme c'est du mésoderme donc je ne peux pas ça veut dire que quand je vais parler de l'ectoderme je vais toujours vous parler de l'ectomésoderme ou de l'endomésoderme parce qu'ils sont ils fonctionnent comme ça par contre quand je vais vous parler purement du mésoderme je vais vous parler du mésoderme avec le mésoderme c'est que la base du crase déjà comme ça c'est un équilibre entre mon neurocrase et mon viscérocra j'ai du mésoderme c'est à dire j'ai du tissu cartilagineux et puis du tissu osseux l'ectoblast va donner tout le tissu nerveux le mésoblast va vous donner tout ce qui est squelettique muscles conjonctifs appareils circulatoires et tout ce qui est rénal ou urogenital tout ce qui est endoblast toutes les glandes digestives tout l'hypothélium digestif et tout l'épithélium respiratoire ton système respiratoire c'est en fait de l'endoderme faite de l'endoderme. C'est le même tissu que le tissu digestif. Maman au niveau original, et ils se soutiennent complètement dans leurs fonctions. En d'autres termes,

un homme neurocrânien, ça correspond à l'ectoderme, ou ça correspond au tissu épithélial ou au tissu de frontière. L'homme viscérocrânien, c'est l'endoderme, donc c'est tout le système digestif, c'est tout le système épithélial. Et l'homme interne, l'homme de type mésodermique, ça correspond à tout le système de soutien, tout le système osseux, tout le système musculosquelettique, tout le système urogenital, tout le système circulatoire du caractère. Le tissu de soutien, ça veut dire le tissu d'intérieur, le tissu qui informe le corps. Donc on va voir qu'on peut définir l'embryon en termes de jours, on peut parler aussi de caractère. L'anégie, je vais vous parler en jours. Quand il y a des synchronicités, des phénomènes, comme la fermeture des neuroports avec l'intégration de ces lômes et des choses comme ça, on vous donnerait le temps. Au moment de la prise de conscience du cœur ou des choses comme ça, on vous donnerait des points précis. Sinon, on parlera de jours ou de semaines. Et aussi, on donnera un peu des notions de taille. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est la notion de croissance. C'est de voir que ça grandit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement développemental dans l'approche. C'est un mouvement qui se développe comme ça, mais ce n'est pas un mouvement qui se fait comme ça. C'est ça la différence entre ce qu'on appelle la motilité et la mobilité. L'un est une réponse embryonnaire, c'est-à-dire qu'elle suit le mouvement du développement, et l'autre est un mouvement purement lié à la respiration et qui va donner des mouvements, et l'autre est un mouvement encore donné à la motricité. Tu vois, il faut bien faire la différence. Quand je bouge comme ça, c'est très différent de ce mouvement au niveau de mon foie. Donc si je veux retravailler un tissu, je le redonne dans sa motilité. Et lui, sa force fonctionnelle, elle est là. Tu vois ? C'est là où elle va reprendre. Et c'est ça le travail qu'on fait, c'est revenir dans ce tissu pour que lui, ok, je me réorganise et là je peux retrouver ma mobilité, Tu comprends ? C'est toujours

suivre le mouvement. Mais là, il faut les points d'appui et avoir le mouvement dans la main. Je ne traite pas un organe. Je traite un environnement. mon action peut être sur motilité, mobilité, motricité. Et là, dans la mobilité, Le maître de la mobilité, c'est le diaphragme. C'est pour ça qu'on va apprendre comment se construit ce diaphragme. Un jour, un enseignant me dit, Marc, un jour, tu vas sentir la puissance dans le tissu. Moi, c'était très intellectuel, la puissance. La puissance. En même temps, intellectuel, je me dis, oui, je peux comprendre Je vois un embryon qui se développe, t'imagines la puissance du truc. dans les stylés, dans certains points d'appui, la puissance, elle est là aussi, tu vois, elle est dingue. Là, tu peux... Il se passe un truc, mais tu ne sais pas créer ça tout le temps. Tu dois essayer de te mettre en présence, d'avoir une bonne connexion, et puis à un moment donné, le système s'ajuste, tu vois. à un moment donné, il me dit, voilà, c'est comme si tu étais sur une petite barque dans la mer, tu vois. Et tu es juste dans l'eau, comme ça, tu vois. Tu ne la vois pas, mais en dessous de toi, il y a une baleine qui arrive. Et toi, tu es juste là, et tu sens. Tu sens tout d'un coup. C'est un peu cette sensation-là, quoi, tu vois. Mais regardez, premier jour, le petit bazar qu'on est. Et regardez ce qui va se passer à la fin du deuxième mois. Regardez en deux mois. Et regardez déjà ici, début du vingtième jour, il y a déjà une forme qui se fait. Là, le potentiel de vie, il est là. Ça, c'est simplement un ovule qui a reçu le patrimoine génétique du père, le spermatozoïde, et les deux patrimoines sont occupés à se rencontrer. C'est à peu près la première image de votre vie. C'est ce qu'on appelle encore la zone pellucida et des cellules nourricières. Encore une couche de cellules importante. Si je prends une cellule et je mets mon noyau au centre de la cellule, en plein centre, elle n'est pas polarisée. Je dois échanger avec qui ? Avec mon environnement. Je dois échanger avec toi. Eh bien, si je crée ici, là, je crée une possibilité d'échange, idem, pour tout mon environnement. Par contre, une

image, et c'est pour ça, reprenez, dans une cellule, dans toutes les cellules de votre corps, le noyau n'est jamais au centre, il est toujours excentré. Et ça, c'est l'image momentanée d'une polarité. Pourquoi ? Parce que si j'ai ici une cellule avec un noyau excentré, j'ai une activité métabolique beaucoup plus importante ici. Et je dois avoir ce champ d'activité plus importante. Ça augmente la force métabolique. Et ça, c'est l'expression de la polarité. Tu vois ? On reprend au stade où je suis un ovocyte. On a vu qu'il avait... Il était polarisé par des petites cellules autour qui avaient libéré des trucs, tu vois ? Qui avaient créé ce qu'on appelle le drapeau de Wolper, tu te souviens ? Je vais créer des concentrations moléculaires au sein même, atomiques au sein même de mon système, qui fait que c'est polarisé, donc il y a une force, il y a un plus et un moins. Le spermatozoïde, quand il arrive, il vient toucher la membrane, on verra en détail, il libère une hormone qu'on appelle la ZP3, qui est un truc très spécifique, mais très intéressant à connaître plus tard. Ma polarité qui est ici, à l'intérieur de l'embryon, c'est comme si j'avais une boussole, avec mon nord et mon sud, sauf que je ne sais pas où est le nord et le sud. Ce n'est pas orienté par rapport à mon environnement, c'est orienté par rapport à mon espace. Et au moment où le spermatozoïde arrive, il y a une réorganisation globale du système par rapport à l'espace. Et le réorg... Le champ électrique se réorganise par rapport à ce niveau-ci. Le champ électrique se réorganise. Il reçoit une information membranaire, il y a une dégranulation corticale qui se fait à l'intérieur pour qu'il n'y en ait qu'un qui passe. C'est une rencontre extraordinaire entre ces deux patrimoines. C'est chaque fois un miracle. tu vois, et là, tout d'un coup, mon ovocyte, il est polarisé et va se créer. La rencontre de mes deux patrimoines, ça va former un noyau, un champ, et où le noyau, si tu veux, il est sur l'axe, entre guillemets, électrique du système, mais il correspond au fait qu'il est excentré, c'est sa réponse, par rapport à la globalité. Maintenant, où

est le plus grand champ électrique de notre corps ? C'est le long de notre colonne vertébrale. Ça, c'est une puissance depuis mon cerveau, il y a un champ électrique très puissant, il y a un grand champ électrique au niveau du cœur, il y a un grand champ électrique ici, électromagnétique, mais l'axe le plus important, c'est le long de ma colonne vertébrale. C'est un lieu d'échange neurologique très important jusqu'au bout de vos doigts, mais il y a une concentration autour. Donc on va faire une pratique et on va imaginer qu'on est juste une cellule. Vous êtes sur la table, une cellule. Nous, on va venir, on ne va pas faire grand-chose. Vous allez vous mettre, simplement. Il y en a un qui va se mettre simplement au pied, tu vois. Toi, tu te mets là-bas, tu dessins un peu plus bas ici. Donc quelqu'un se met ici, mais on s'en fout comment on touche. La seule chose, c'est qu'on touche, vous pouvez toucher ici, vous pouvez toucher ici. La seule chose, c'est qu'on touche doucement. C'est quand tout le monde... Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là, tu prends une chaise, toi tu prends une chaise, tu te mets ici. Quand tu te mets là, et on va voir dans l'embryologie qu'on part de là et on revient là. C'est comme si, à un moment donné, on va partir, on est dans le vide, et puis tout d'un coup, on va être attaché par un filet comme ça, dans l'univers, tu vois, dans l'univers de la mer. Et puis tout va se développer, tout va revenir autour. Comme ça. On part d'un pédicule vers un cordon. Tout s'intègre ici. Le nombril, il est toujours à la bonne place. Parfois c'est nous qui n'est pas à la bonne place. Sous-titres par Jérémy Diaz On ne va rien essayer de faire comme ça, non. On revient dans tout ça. Parce que lui, il est connecté avec ce qu'on appelle le ciel antérieur, le ciel postérieur, et tout ce truc. On va simplement, nous, en se mettant là, simplement se mettre sur cette référence et laisser voir comment le corps, Sous-titrage ST' 501 il s'organise tout seul. Il faudra apprendre à reconnaître dans la pratique. Tout d'un coup, tout d'un coup, il y a un processus qui peut s'installer. Et ça, il faut l'accompagner. Parce que c'est la santé qui se

met à travailler. Il faut l'accompagner. On est... On est hypnotisé par la lésion. On est attiré par la lésion. Et là, moi je vous propose, dans le travail qu'on va faire avec l'embryologie, cette biodynamique, c'est, je t'ai vu, mais je ne pars pas avec toi. mais tu reconnais mais moi je reste sur la santé Je reste dans la dynamique de la santé. Je suis sur le fulcrum de santé. Je suis sur le... Je reste dessus. Je voudrais vous partager un petit film d'un maître d'Alkidu. Il y a deux, trois petites choses. On a parlé tout à l'heure de la notion d'espace, la notion d'unité. Et la notion de globalité, la notion aussi un petit peu d'harmonie, des choses comme ça. Vous faites un geste, c'est que vous prenez un bébé, comme si vous preniez un espace. prenez pas un bébé comme ça, tu prends un bébé comme ça, tu prends, tu vois, tu prends vraiment tout, tout l'espace. Ce que je veux vous ouvrir, c'est cette notion d'espace, parce qu'on va travailler avec des points de silence, on va aller rechercher des points d'appui dans le corps, mais à différentes profondeurs dans le silence qu'il faut toucher. Il y a un silence, on va dire premier, et puis il y a des silences de plus en plus profondes, qui sont aussi reliées à des espaces. C'est comme si on va devoir prendre conscience de l'espace du corps, prendre conscience de l'espace, de cette énergie qui est un peu autour de moi, prendre conscience de la pièce, prendre conscience aussi vraiment de l'espace. Et si on arrive petit à petit à cette profondeur, vous allez voir qu'il y a des qualités, ça se dit ça, des qualités de silence qui sont... différentes. Et on va tenter petit à petit, dans le travail qu'on va petit à petit commencer à faire ensemble, d'aller rechercher cette qualité de silence. Parce que le corps, il a besoin de ces points d'appui, de ces points de silence pour engendrer et transformer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? C'est un onglet facile. C'est un onglet facile. Et ce qu'il fait là, il ramène sa conscience, son mental, dans son centre de gravité. Il fait même un mouvement en haut. Il ressent son énergie ici. C'est un centre d'énergie important. On va le voir aussi, rien que

sur le plan biologique, le lesbianisme. Il rassemble cette énergie ici. Il se recentre dans son énergie vitale. Il y a tellement de jeunes violents aujourd'hui qui n'ont pas d'exemple, ni d'amour, ni d'attention, et qui ont seulement dans leur tête des images de la violence, de la télévision, de l'air. Est-ce possible de prendre un groupe de ces jeunes qui n'ont aucune idée de ce que vous essayez de leur donner ? Est-ce possible de prendre un groupe de ces jeunes et de leur transmettre ce sens totalement différent de valeurs ? Est-ce possible ?

Sous-titrage ST' 501 D'abord, il faut s'assurer que le non-battre n'est pas un bâtiment d'évasion. Par exemple, si la violence vient de cette façon, si vous y allez de cette façon, vous vous éviterez. Alors que si vous y allez de l'autre côté, vous vous résisterez. Donc le non-battre signifie ne pas éviter, ne pas résister. Comment pouvez-vous faire cela ? Vous devez savoir comment rester où vous êtes. Vous êtes ici, vous restez où vous êtes. Comment le faites-vous ? Vous le faites avec cette perception de l'espace. C'est ça, le tambour. Donc, n'en faites pas contre, mais ne l'avouez pas, mais fermez les yeux et percevez le espace, et puis, d'abord, bougez votre corps en haut, et puis arrêtez la perception, encore, en haut. Et restez là où vous êtes. Et puis il reste sans se battre. Ok, essayez votre part. Quand je pousse, avec les yeux fermés, et que je vois l'espace autour, ce espace ne se déplace pas. C'est la bonne façon de s'arrêter. Si vous voulez en faire plus, faites ceci. Chaque fois, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous arrêtez, vous arrêtez. stop yes this is Ok, et là, je le fais moi-même. Donc les yeux fermés, chaque fois que vous essayez de vous arrêter avec la perception. Ensuite, vous devez savoir comment bouger sans bouger. C'est-à-dire qu'il faut bouger son corps sans bouger son esprit. Et ici, c'est-à-dire que votre esprit est dans l'espace. Vous êtes ici, dans cet espace. Donc cette perception de l'espace ne bouge pas. Donc c'est ici. il ya Si je vais là-bas, c'est de la lutte. Si je vais de cette façon, c'est d'éviter. Donc, juste arrêtez, je stoppe ici, et maintenant, je vais juste garder

cet espace. Cela signifie qu'il n'y a pas de lutte. Si ici, vous vous posez, de cette façon, c'est de la lutte. Donc ici, vous vous posez, et cet espace ne se déplace pas. Ok, première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Non-conflit, pour le non-conflit, vous gardez cette perception de l'espace et vous avancez. C'est différent de ça. Pousse-tout. Pousse-tout. Pousse-tout. She's stronger than I am. She's stronger than I am. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Comment bouger les autres sans les bouger ? Ok, alors pratiquons. Si je veux bouger son corps, peut-être que je peux, mais ça me dérange. Donc maintenant, bouger mon corps sans bouger signifie qu'il y a un espace. dans lequel son corps est il peut bouger dans l'espace sans bouger son corps cela signifie qu'ici il prend juste l'espace c'est bouger les autres sans bouger oui oui oui c'est ça vous avez quelque chose à dire ? oui oui c'est ça si je veux te bouger comme ça ça devient un conflit – Sous-titrage FR 2021 Juste comme prendre un bébé, ici il y a un espace, et je prends tout l'espace. Cela signifie de bouger sans bouger. Juste bouger tout l'espace. C'est ce que vous faites quand vous bougez des bébés. Les bébés, vous ne bougez pas comme ça. Vous êtes en haut et en bas. Donc vous pouvez faire ça même sans le bébé. Et vous essayez de pousser la main ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Merci. C'est beaucoup plus facile, non ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Et puis, ici, c'est l'Aïkido Beaucoup de gens se confondent avec le respect et l'admiration, mais ce dont nous avons besoin n'est pas de l'admiration, mais du respect. Le respect signifie ne pas perturber cette personne. Mais comment pouvons-nous nous déplacer sans nous perturber ? Si nous déplaçons l'espace, nous pouvons déplacer cette personne avec respect. Cela signifie que nous ne devons pas nous perturber. C'est ce qu'est l'Aïkido. Dans l'Aïkido, vous devez traiter tout le monde, dans toutes les circonstances, avec respect. Pour beaucoup de gens, quand ils sont amoureux, ils disent « Oh, bonjour » et ils sont très souriants, etc. Mais quand certains ne

sont pas amoureux, ils commencent immédiatement à se battre. Cela signifie ne pas garder une relation collective avec les autres dans toutes les circonstances. So, going to Hanset. Sous-titrage FR ? Donc ici, si je veux le bouger, il s'accroche et il n'a pas de respect. Donc, le espace ici. Donc, d'abord, j'attrape ce espace avec cette main. – Sous-titrage FR 2021 Et maintenant, cette main est à l'intérieur, donc elle s'accroche. Donc, vous mettez votre main à l'extérieur de l'espace. Et puis, gardez cet espace. Donc, ici, il y a un espace, et vous mourez cet espace, avec un partenariat déstabilisant. Donc, ici, d'abord, cette main, et puis, mettez-la à l'extérieur, et puis, vous mourez. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un espace. Sous-titrage FR ? Et je me suis dit, « Ah, il y a un mot très aïe de musée ! » Oui, il y a beaucoup d'énergie. Donc, il y a un mot très aïe de musée. Sous-titrage ST' 501 et et et et et et et et et et et et Oh, mon Dieu ! Bien, première zone. Remet les oeufs et récupérez tous vos corps. On va lire le corps de Philippe. Remet les oeufs. la zone A. C'est plus autour de vous, vous émettez un rayonnement. Il y a la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et puis il y a l'horizon, qui correspond à la zone. on va aller rechercher chaque espace, petit à petit, on va commencer par le début Sous-titrage ST' 501 de retrouver ce point du silence. Quand je rentre dans une pièce, très vite je recherche comment je me situe dans cette pièce, comment elle se passe autour de moi, comment je peux me positionner pour être bien. positionner. Moi, dans la pratique de l'embryologie qu'on va faire, On va travailler avec ces espaces. Le corps va se réorganiser par rapport à cet espace. L'espace, il est là. C'est juste être en adéquation.